

A · SITUS E POSIÇÃO4C

☐ Situs abdominal

Estômago à esq · Fígado à dir · **Situs solitus**

☐ Posição do coração

Levocardia · Hemitórax esquerdo

☐ Eixo cardíaco

45° ± 20° (30–60°) em relação ao eixo sagital

☐ Tamanho cardíaco

Área ≤ **1/3** do tórax · Razão CT/T < 0,5

D · VEIAS PULMONARESColor

☐ Drenagem no AE

≥ **1–2 veias** com fluxo confirmado no AE

☐ Tamanho do AE

Proporcional ao AD · Sem hipoplasia

☐ Veia ázigos

Não dilatada · Sem sinal de "dupla aorta"

G · DOPPLER — CANAL ARTERIAL (DUCTO)PW · Color

☐ Permeabilidade e direção do fluxo

Fluxo **anterógrado** AP → Ao descendente · Sem restrição

☐ Velocidade sistólica de pico

≤ **140 cm/s** · Aumenta com IG · Acima de 140 cm/s = alterado

☐ Velocidade diastólica

≤ **30 cm/s** · Fluxo anterógrado presente · Acima de 30 cm/s = alterado

☐ Índice de pulsatilidade (IP)

IP ≥ 2,2 · Valores abaixo de 2,2 sugerem constrição ductal

J · SINAIS DE ALERTA — EXCLUIRCRÍTICO

• CoAo: VD>>VE + istmo estreito + arco hipoplásico

• TGA: grandes artérias paralelas (sem cruzamento ~90°)

• SHCE: VE filiforme + Ao asc. hipoplásica + fluxo retrógrado no arco

• RVAPT: AE pequeno + ausência de VP drenando no AE

• Estenose Ao crítica: V_{Ao} >120 cm/s + VE dilatado

• Constrição ductal: V sist. >140 cm/s · V diast. >30 cm/s · IP <2,2

• Bloqueio AV 3°: FC <60 bpm + dissociação AV

• Hidropisia: derrame pericárdico + pleural + edema de pele

B · CÂMARAS CARDÍACAS4C

☐ Simetria VD / VE

VD ≈ VE · Razão < 1,6 · Sem câmara dominante

☐ Septo interventricular

Íntegro em toda extensão · Sem dropout

☐ Forame oval

Pérvio (normal) · Fluxo AD → AE ao color

☐ Valvas AV — morfologia

Tricúspide mais baixa (**offset** normal) · Sem espessamento

☐ Contratilidade miocárdica

Espessamento sistólico **simétrico** · Sem disfunção

E · VIAS DE SAÍDA — MODO B5C / RVOT

☐ Origem da aorta

Nasce do **VE** · Continuidade MV–Ao visível

☐ Origem da pulmonar

Nasce do **VD** · Conus subpulmonar presente

☐ Cruzamento Ao × AP

Artérias cruzam em **~90°** · Não paralelas

☐ Calibres das artérias

AP ≥ Ao · Sem hipoplasia de nenhum vaso

F · ARCO AÓRTICO / 3 VASOS3VT

☐ Alinhamento 3 vasos

AP > Ao > VCS · Alinhados em curva · Ao à esq. da VCS

☐ Istmo aórtico

Calibre **normal** para IG · Z-score > –2

☐ Lateralidade do arco

Arco à **esquerda** da traqueia (normal)

☐ Ducto arterioso

Pérvio · Fluxo **anterógrado** AP → Ao descendente

I · RITMO E FREQUÊNCIAM / PW

☐ Frequência cardíaca

120–160 bpm · Regular · Sem pausas

☐ Relação AV (M-mode)

1:1 · Cada átrio seguido de ventrículo

☐ Extrassístoles

Ausentes ou isoladas/raras sem repercussão

CONCLUSÃO DO EXAME

☐ Normal

Todas as janelas dentro da normalidade

☐ Inconclusivo

Janela inadequada — repetir em 2–4 sem.

☐ Alterado — acompanhamento

Achado sem cardiopatia crítica

☐ Cardiopatia crítica

Encaminhar ao centro de referência

OBSERVAÇÕES _____

Protocolo Caliper · Ecocardiograma Fetal